

INFORME DE EVALUACIÓN NEUROPSICOLÓGICA

— Variante Profesional —

PACIENTE

Beatriz Helena Rincón Pardo

DOCUMENTO

CC 41356789

FECHA NACIMIENTO

25/08/1943

EDAD

82 años, 9 meses

SEXO

Femenino

ESCOLARIDAD

Primaria Completa

LATERALIDAD

Diestra

FECHA DE EVALUACIÓN

23/06/2026

ORDEN N°

OM-2026-001253

PROTOCOLO APLICADO

Neuronorma Colombia AM + MMSE + GDS-15 + Lawton

INFORMACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA

Nombre:	Beatriz Helena Rincón Pardo	Lateralidad:	Diestra
Documento:	CC 41356789	Ocupación:	Pensionada
Fecha de nacimiento:	25/08/1943	Ciudad:	Tunja, Boyacá
Edad:	82 años, 9 meses	Acompañante:	Camilo Rincón Vargas
Sexo:	Femenino	Remite:	Médico familiar
Escolaridad:	Primaria Completa	EPS / Asegurador:	Nueva EPS

MOTIVO DE CONSULTA

Deterioro cognitivo de 4 años. Curso escalonado con episodios de empeoramiento súbito. Antecedente de 3 ACV lacunares. Síntomas disejecutivos predominantes. Dificultad para cocinar, finanzas, planificación.

PRUEBAS APLICADAS

Protocolo: Neuronorma Colombia AM + MMSE + GDS-15 + Lawton

Prueba	Dominio	Dur.
TMT A	Atención	—
TMT B	Funciones Ejecutivas	—
Span Retención Dígitos Directo	Memoria de Trabajo	—
Span Retención Dígitos Inverso	Memoria de Trabajo	—
Test de Stroop Palabra	Atención	—
Test de Stroop Color	Atención	—
Test de Stroop Palabra/Color	Atención	—
Fluidez Verbal Animales	Lenguaje - Fluidez	—
Fluidez Verbal Fonémica (P)	Lenguaje	—
AM Deno	Lenguaje	—
Grober RL Ensayo 1 (libre)	General	—
Grober RLT - Retención Libre Total (E1+E2+E3)	General	—
Grober RT - Recuerdo Total Claves (E1+E2+E3)	General	—
Escala de Depresión Geriátrica Yesavage	Socioemocional - Depresión	—
Mini-Mental State Examination (MMSE)	General	—
Escala de Lawton y Brody (IADL)	General	—

ANTECEDENTES

Patológicos / Médicos

Sin antecedentes médicos de relevancia.

Farmacológicos

Sin medicación actual.

Familiares

Sin antecedentes neuropsiquiátricos de primer grado.

Psiquiátricos

Antecedente de trastorno depresivo en tratamiento con sertralina 50 mg/día.

Traumáticos

Niega TEC.

RESUMEN EJECUTIVO

Pirámide invertida: conclusión, hallazgos, implicación

Conclusión

Perfil neuropsicológico global: $Z = -1.3\sigma$ sobre 5 dominios evaluados.

Hallazgos clave

- Atención moderadamente descendido ($Z = -1.7\sigma$)

Implicación

Se sugiere intervención dirigida al dominio descendido, con monitoreo de respuesta a tratamiento.

OBSERVACIÓN CLÍNICA

Hallazgos cualitativos durante la administración

Apariencia y conducta

Evaluación neuropsicológica completa. Paciente colaborador. Sin incidentes durante la aplicación.

Memoria

Memoria episódica anterógrada descendida. Mejor reconocimiento que evocación libre. Perfil compatible con demencia vascular.

Praxias y gnosias

Sin alteraciones significativas en praxias ni gnosias.

Lenguaje

Anomia moderada. Parafasias. Comprensión de órdenes complejas descendida. Fluidez fonémica y semántica severamente comprometidas.

Funciones ejecutivas

Síndrome disejecutivo predominante. Déficit severo en planificación, flexibilidad y monitorización. Perfil subcortical-frontal.

Cociente intelectual (observación)

Perfil cognitivo global: F01.9 - Demencia vascular sin complicaciones

RESULTADOS CUANTITATIVOS

Puntajes por prueba y perfil cognitivo del paciente

Escala de Depres

6

Deficit Leve

Mini-Mental Stat

17

Deficit Extremo

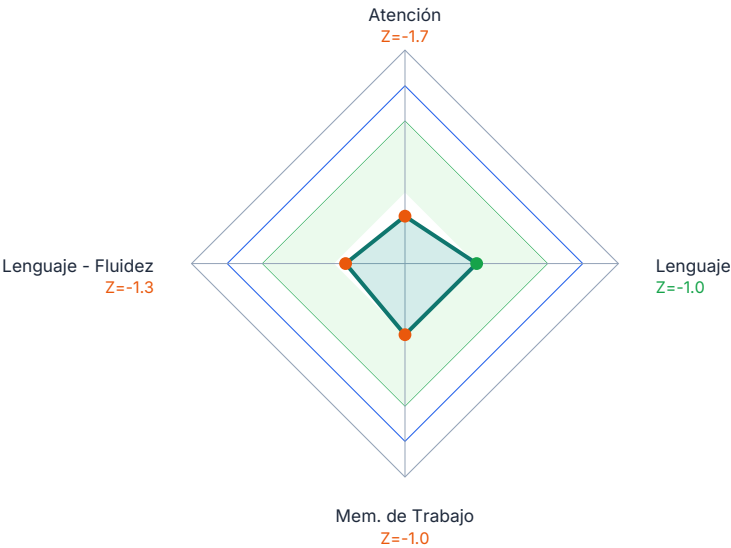
Escala de Lawton

3

Deficit Extremo

Perfil cognitivo por dominio

Cada eje representa un dominio cognitivo. El polígono teal muestra el Z del paciente; la franja verde central equivale al rango normal (-1 a +1 σ).

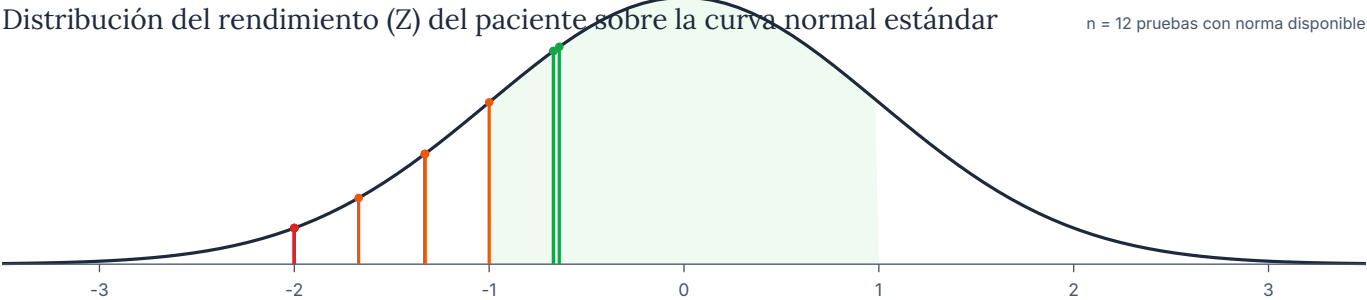


Curva normal con puntajes Z del paciente

Eje horizontal: puntaje Z (unidades de desviación estándar). Las marcas rojas son los puntajes del paciente sobre la curva.

Distribución del rendimiento (Z) del paciente sobre la curva normal estándar

n = 12 pruebas con norma disponible



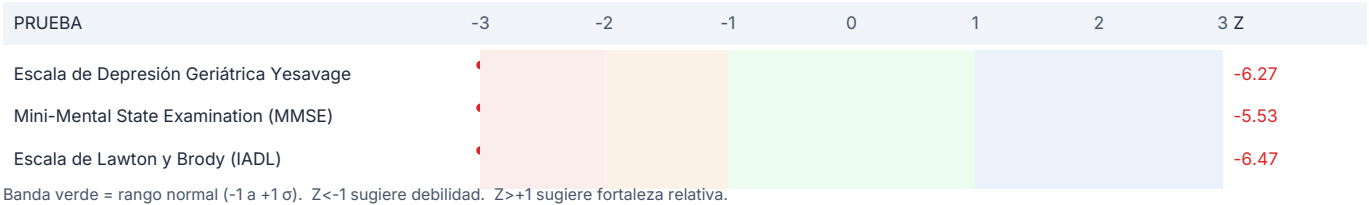
Perfil Z por prueba

PRUEBA	-3	-2	-1	0	1	2	3 Z
--------	----	----	----	---	---	---	-----

Perfil Z por prueba

Eje horizontal: puntaje Z (rango -3 a +3). Verde = zona normal; rojo/naranja = debajo del promedio; azul = por encima.

PRUEBA	-3	-2	-1	0	1	2	3 Z
TMT A							-1.00
Span Retención Dígitos Directo							-1.33
Span Retención Dígitos Inverso							-0.67
Test de Stroop Palabra							-2.00
Test de Stroop Color							-2.00
Test de Stroop Palabra/Color							-1.67
Fluidez Verbal Animales							-1.33
Fluidez Verbal Fonémica (P)							-1.33
AM Deno							-0.64
Grober RL Ensayo 1 (libre)							-2.00
Grober RLT - Retención Libre Total (E1+E2+E3)							-0.67
Grober RT - Recuerdo Total Claves (E1+E2+E3)							-2.00



Semáforo de dominios cognitivos

DOMINIO	Z	BANDA
Atención	-1.67σ	moderado
General	-1.56σ	moderado
Lenguaje - Fluidez	-1.33σ	moderado
Memoria de Trabajo	-1.00σ	moderado
Lenguaje	-0.99σ	promedio

Tabla detallada de puntajes

Prueba	PD	Escalar/CI	Z	Interpretación
TMT A	201	7	-1.00	Promedio
TMT B	—	—	—	Sin dato
Span Retención Dígitos Directo	3	6	-1.33	Límitrofe
Span Retención Dígitos Inverso	1	8	-0.67	Promedio
Test de Stroop Palabra	25	4	-2.00	Bajo
Test de Stroop Color	19	4	-2.00	Bajo
Test de Stroop Palabra/Color	7	5	-1.67	Límitrofe
Fluidez Verbal Animales	7	6	-1.33	Límitrofe
Fluidez Verbal Fonémica (P)	4	6	-1.33	Límitrofe
AM Deno	26	26	-0.64	Promedio
Grober RL Ensayo 1 (libre)	3	4	-2.00	Bajo
Grober RLT - Retención Libre Total (E1+E2+E3)	5	8	-0.67	Promedio
Grober RT - Recuerdo Total Claves (E1+E2+E3)	6	4	-2.00	Bajo
Escala de Depresión Geriátrica Yesavage	6	6	-6.27	Deficit Leve
Mini-Mental State Examination (MMSE)	17	17	-5.53	Deficit Extremo
Escala de Lawton y Brody (IADL)	3	3	-6.47	Deficit Extremo

SÍNTESIS CLÍNICA INTEGRADORA

Lectura cuantitativa de los hallazgos

El perfil neuropsicológico evidencia debilidades en: atención (moderadamente disminuido, Z=-1.7); general (moderadamente disminuido, Z=-1.6); lenguaje - fluidez (moderadamente disminuido, Z=-1.3); memoria de trabajo (moderadamente disminuido, Z=-1.0).

Entre las pruebas con mayor desviación se encuentran Test de Stroop Palabra (Z=-2.00, bajo); Test de Stroop Color (Z=-2.00, bajo); Grober RL Ensayo 1 (libre) (Z=-2.00, bajo). Estos hallazgos orientan la formulación diagnóstica y la priorización de objetivos de intervención.

Áreas con desempeño disminuido

- Grober RL Ensayo 1 (libre) — bajo ($Z=-2.00$)
- Grober RT - Recuerdo Total Claves (E1+E2+E3) — bajo ($Z=-2.00$)
- Test de Stroop Color — bajo ($Z=-2.00$)
- Test de Stroop Palabra — bajo ($Z=-2.00$)
- Test de Stroop Palabra/Color — limítrofe ($Z=-1.67$)
- Fluidez Verbal Animales — limítrofe ($Z=-1.33$)

RESUMEN PARA LA FAMILIA

Lenguaje sencillo para padres, cuidadores y paciente

Saludo

Este es un resumen de la evaluación que se realizó Beatriz. Está escrito en un lenguaje sencillo para que sea fácil de entender. Tu psicólogo o psicóloga te explicará los detalles y resolverá cualquier duda que tengas.

¿Qué hicimos en la evaluación?

Realizamos varias pruebas que miden cómo funciona tu cerebro en distintas situaciones: memoria, atención, lenguaje, razonamiento y la velocidad con la que procesas información. Las pruebas son como "pequeños retos" que se resuelven con papel, lápiz y a veces con cubos o figuras. No hay respuestas buenas ni malas: lo que nos interesa es conocer cómo trabaja tu mente.

¿Qué encontramos?

Las áreas donde te fue bien incluyen: En TMT A, tu rendimiento fue dentro del rango esperado. En Span Retención Dígitos Inverso, tu rendimiento fue dentro del rango esperado. En ViDeno, tu rendimiento fue dentro del rango esperado. Las áreas donde se recomienda trabajar incluyen: En Span Retención Dígitos Directo, tu rendimiento estuvo en el límite (Limítrofe). Vale la pena acompañarlo de cerca. En Test de Stroop Palabra, encontramos un rendimiento por debajo del promedio. Es importante que converses con tu psicólogo/a sobre qué significa esto y qué apoyos podrían ayudarte. En Test de Stroop Color, encontramos un rendimiento por debajo del promedio. Es importante que converses con tu psicólogo/a sobre qué significa esto y qué apoyos podrían ayudarte.

Implicaciones para la vida diaria

Además de los puntajes, esto es lo que podría notarse en la vida cotidiana:

Atención · moderado

- Mantener el foco en una conversación larga (especialmente en reuniones o clases).
- Seguir instrucciones de varios pasos sin perder algún detalle.
- Filtrar estímulos distractores en lugares ruidosos o con mucha gente.

Apoyos sugeridos: Dividir el trabajo en bloques de 20-25 minutos con pausas activas. · Usar temporizadores visuales (Time Timer) y listas de verificación.

General · moderado

- Tareas que dependen de esta función pueden requerir más esfuerzo o tiempo.
- Rendimiento bajo comparado con pares de la misma edad y escolaridad.

Apoyos sugeridos: Practicar con constancia y paciencia. · Acompañar el proceso con apoyo profesional y familiar.

Lenguaje - Fluidez · moderado

- Tareas que dependen de esta función pueden requerir más esfuerzo o tiempo.
- Rendimiento bajo comparado con pares de la misma edad y escolaridad.

Apoyos sugeridos: Practicar con constancia y paciencia. · Acompañar el proceso con apoyo profesional y familiar.

Memoria de Trabajo · moderado

- Hacer una operación mental mientras se recuerda otra cosa (ej. contar hacia atrás desde 100 de 7 en 7).
- Anotar un teléfono mientras se escucha otra indicación.
- Seguir una receta de cocina o instrucciones de varios pasos.

Apoyos sugeridos: Repetir en voz alta lo que se acaba de escuchar. · Anotar inmediatamente la información importante.

Áreas para apoyar (en qué trabajar)

- En TMT A, tu rendimiento fue dentro del rango esperado.
- En Span Retención Dígitos Inverso, tu rendimiento fue dentro del rango esperado.
- En ViDeno, tu rendimiento fue dentro del rango esperado.
- En Grober RLT - Retención Libre Total (E1+E2+E3), tu rendimiento fue dentro del rango esperado.
- En Span Retención Dígitos Directo, tu rendimiento estuvo en el límite (Límitrofe). Vale la pena acompañarlo de cerca.
- En Test de Stroop Palabra, encontramos un rendimiento por debajo del promedio. Es importante que converses con tu psicólogo/a sobre qué significa esto y qué apoyos podrían ayudarte.
- En Test de Stroop Color, encontramos un rendimiento por debajo del promedio. Es importante que converses con tu psicólogo/a sobre qué significa esto y qué apoyos podrían ayudarte.
- En Test de Stroop Palabra/Color, tu rendimiento estuvo en el límite (Límitrofe). Vale la pena acompañarlo de cerca.
- En Fluidez Verbal Animales, tu rendimiento estuvo en el límite (Límitrofe). Vale la pena acompañarlo de cerca.

¿Qué recomendamos?

Sobre la terapia: continúa con tus sesiones según lo acordado. Si tienes dudas, coméntalas con tu terapeuta.

Preguntas frecuentes

¿Mis resultados son permanentes?

No necesariamente. El cerebro puede cambiar con el tiempo, especialmente con práctica, con los apoyos adecuados y con un buen ambiente. Estos resultados son una foto del momento actual: tu psicólogo/a te ayudará a entender qué puede cambiar y qué se mantiene más estable.

¿Por qué algunos resultados son mejores que otros?

Es completamente normal. Todas las personas tienen áreas donde son más fuertes y áreas donde pueden mejorar. Esto NO significa que haya algo mal: el cerebro humano es diverso y cada uno tiene su propio perfil.

¿Qué significa un puntaje 'bajo' o 'muy bajo'?

Significa que, comparado con personas de la misma edad y nivel educativo, esa función específica rindió por debajo de lo esperado. NO es un diagnóstico en sí mismo. Es una señal para profundizar, entrenar y apoyar esa área. Tu psicólogo/a te explicará si requiere intervención profesional adicional.

¿Qué es el 'cociente intelectual' (CI)?

El CI es un número que resume el rendimiento global en diversas pruebas. NO define tu inteligencia total ni tu valor como persona: es solo una medida parcial de ciertas habilidades de razonamiento, memoria y atención. Varía según el contexto, la fatiga, el ánimo del día y muchos otros factores.

IMPRESIÓN DIAGNÓSTICA

DSM-5 / CIE-10

Diagnóstico codificado

Código CIE-10: F01

Impresión diagnóstica: F01.9 - Demencia vascular sin complicaciones

RECOMENDACIONES

Plan de manejo agrupado por área y prioridad

- Se recomienda seguimiento clínico y plan terapéutico según hallazgos. Reevaluación en 6-12 meses si aplica.